

TEMA 10.35 • REUMATOLOGÍA

Lumbago Mecánico y Cervicalgia Mecánica

PERFIL EUNACOM 1.11.1.013

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

El **lumbago mecánico** y la **cervicalgia mecánica** son cuadros caracterizados por dolor localizado en la región lumbar o cervical, respectivamente. Se analizan en conjunto debido a que comparten una fisiopatología, presentación clínica y pilares de tratamiento muy similares.

Clínica y Presentación

El sello distintivo de estos cuadros es su relación con el esfuerzo físico y el movimiento.

- **Inicio:** Suele ser súbito, gatillado por un esfuerzo (ej. levantar un objeto pesado, un movimiento brusco en el cuello durante el ejercicio).
- **Intensidad:** Puede ser muy intenso e invalidante durante los primeros días.
- **Comportamiento del dolor:**
 - **Aumenta con el movimiento** y en ciertas posiciones de carga.
 - **Disminuye con el reposo** o en posiciones que descargan la zona afectada.

NOTA CLÍNICA

Fisiopatología: El dolor mecánico suele derivar de la sobrecarga de estructuras musculoesqueléticas (músculos, ligamentos, facetas articulares) sin que exista necesariamente una lesión estructural grave o una inflamación sistémica subyacente.

Signos de Alarma (Red Flags)

Lo más importante en la evaluación inicial es descartar que el dolor sea secundario a una causa orgánica grave. La presencia de cualquiera de los siguientes puntos obliga a realizar un estudio de imágenes y una evaluación más profunda:

- **Déficit neurológico:** Pérdida de fuerza (paresia), alteración de reflejos o pérdida de sensibilidad objetiva.
- **Lumbago de ritmo inflamatorio:** Dolor que aumenta con el reposo y disminuye con la actividad física (típico de espondiloartropatías).
- **Baja de peso involuntaria o antecedente de cáncer:** Sospecha de metástasis óseas.
- **Fiebre:** Puede indicar una infección (espondilodiscitis) o un proceso neoplásico.
- **Traumatismo reciente, Osteoporosis o uso crónico de Corticoides:** Aumentan el riesgo de **fracturas vertebrales**.

TABLA 10.35.1: SIGNO DE ALARMA VS SOSPECHA CLÍNICA ASOCIADA

SIGNO DE ALARMA	SOSPECHA CLÍNICA ASOCIADA
Déficit neurológico focal	Compresión radicular o medular
Fiebre + Dolor local	Espondilodiscitis / Absceso epidural
Antecedente de Cáncer / Baja de peso	Metástasis vertebrales
Trauma / Corticoides / Edad avanzada	Fractura vertebral por compresión
Dolor que empeora en reposo	Espondiloartritis anquilosante / Inflamatorio

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Pregunta de Examen: La **irradiación del dolor** (hacia la pierna en el lumbago o hacia el brazo en la cervicalgia) **NO es un signo de alarma** por sí sola. Cambia el nombre del cuadro a **Lumbosciática** o **Cérvicobraquialgia**, pero si no hay déficit neurológico motor o sensitivo objetivo, el manejo inicial sigue siendo conservador.

Manejo Inicial del Cuadro Agudo

Para un lumbago o cervicalgia mecánica sin signos de alarma, el manejo es conservador y ambulatorio:

- **Reposo relativo:** No se recomienda el reposo en cama absoluto prolongado, ya que retrasa la recuperación. Se debe evitar el esfuerzo que gatilló el dolor.
- **Farmacoterapia:** Uso de **AINEs** (Antiinflamatorios No Esteroidales) por periodos cortos para el alivio sintomático.
- **Educación al paciente:** Explicar que es un cuadro benigno pero que puede durar algunos días o incluso semanas.
- **Kinesioterapia:** Fundamental para el manejo a largo plazo. Se enfoca en:
 - Fortalecimiento de la musculatura del "core" (abdominales y paravertebrales).
 - Educación postural.
 - Prevención de recurrencias (el lumbago es una enfermedad crónico-recidivante).

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

El fortalecimiento muscular es clave. La debilidad de la musculatura estabilizadora favorece posturas viciosas que perpetúan el dolor y facilitan nuevas crisis.

Estudio de Imágenes: ¿Cuándo solicitarlas?

En el lumbago mecánico simple **no se piden imágenes** (ni radiografías, ni TAC, ni resonancia). La correlación entre hallazgos imagenológicos (como discopatías leves) y el dolor clínico es baja en la población general.

- Se solicita **Resonancia Magnética (RM)**, que es el examen de elección, solo en las siguientes situaciones:
- Presencia de **signos de alarma** (especialmente déficit neurológico).
- **Falla del tratamiento médico:** Si el paciente no mejora nada en 1 a 2 semanas.
- **Persistencia de síntomas:** Si después de 6 semanas de tratamiento adecuado el paciente sigue con síntomas significativos.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Para el estudio de patología de columna en el EUNACOM, si se decide estudiar, la **Resonancia Magnética** es superior a la radiografía y al TAC para evaluar médula, raíces nerviosas y discos intervertebrales.

Criterios de Derivación y Cirugía

La gran mayoría de los pacientes con lumbago, lumbosciática o hernias del núcleo pulposo (HNP) **no requieren cirugía**. El tratamiento médico suele ser exitoso.

- **Indicaciones de Cirugía:**
- **Déficit neurológico severo o progresivo:** Signos de compresión medular o un **Síndrome de Cauda Equina** (anestesia en silla de montar, disfunción de esfínteres). Esto es una urgencia.
- **Dolor intratable:** Fracaso del manejo médico bien llevado (incluyendo fármacos y kinesioterapia) en presencia de una causa anatómica operable (como una HNP o una raquiestenosis).

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

La cirugía innecesaria o apresurada en lumbagos mecánicos no asegura mejores resultados y añade riesgos quirúrgicos y costos elevados. Siempre debe intentarse un manejo médico óptimo primero, a menos que exista un compromiso neurológico agudo grave.

Resumen para el EUNACOM

- **Mecánico:** Duele al moverse, alivia al descansar. Sin fiebre ni baja de peso. - **Tratamiento:** AINEs + Reposo relativo + Kinesioterapia. - **Imágenes:** Solo si hay Red Flags o si no mejora en 2-6 semanas. - **Examen de elección:** Resonancia Magnética Nuclear. - **Cirugía:** Reservada para déficit neurológico grave o falla refractaria del tratamiento médico con causa demostrable.
Artículos relacionados: **Hernia del Núcleo Pulposo, Espondiloartropatías, Mielopatía Cervical.**

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Paciente con lumbago agudo tras levantar peso, sin déficit neurológico ni otros signos de alarma. ¿Cuál es la conducta más apropiada?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Lumbago Mecánico y Cervicalgia Mecánica. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Lumbago mecánico: dolor que aumenta con movimiento y disminuye con reposo; inicio súbito relacionado a esfuerzo
- Signos de alarma: déficit neurológico (el más importante), lumbago inflamatorio, baja de peso/cáncer, fiebre, traumatismo/osteoporosis
- La irradiación del dolor NO es signo de alarma (lumbociática/cervicobraquialgia no implica gravedad)
- No pedir imágenes en lumbago mecánico sin signos de alarma
- Resonancia magnética: indicada con signos de alarma, no mejoría en 2 semanas, o persistencia >6 semanas
- Manejo: reposo relativo + AINEs en agudo; kinesioterapia de fortalecimiento para prevenir recurrencias
- Cirugía solo en compresión medular/cauda equina o lumbago refractario con causa operable

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (LUMBAGO MECÁNICO Y CERVICALGIA MECÁNICA)

PREGUNTA 1

Paciente con lumbago agudo tras levantar peso, sin déficit neurológico ni otros signos de alarma. ¿Cuál es la conducta más apropiada?

- A)** Solicitar resonancia magnética de columna lumbar
- B)** Solicitar radiografía de columna lumbar
- C)** Reposo relativo y AINEs
- D)** Derivar a cirugía
- E)** Solicitar TAC de columna

PREGUNTA 2

Paciente con lumbago que se irradia a pierna derecha, sin alteración de reflejos ni de fuerza. ¿Es un signo de alarma?

- A)** Sí, la irradiación siempre es signo de alarma
- B)** No, la irradiación no es signo de alarma; el signo de alarma es el déficit neurológico
- C)** Sí, requiere resonancia de urgencia
- D)** Sí, requiere cirugía inmediata
- E)** No, pero requiere radiografía

PREGUNTA 3

¿Cuándo se indica resonancia magnética en un lumbago mecánico sin signos de alarma?

- A)** Siempre al inicio
- B)** A las 48 horas si no mejora
- C)** Si no mejora en 2 semanas o persiste más de 6 semanas
- D)** Solo si hay irradiación a la pierna
- E)** Nunca en lumbago mecánico

RESUMEN: LUMBAGO MECÁNICO Y CERVICALGIA MECÁNICA

El lumbago mecánico y la cervicalgia mecánica se presentan con inicio súbito en relación a esfuerzo, son intensos e invalidantes inicialmente, y se caracterizan porque el dolor aumenta con el movimiento y disminuye con el reposo (lo opuesto al inflamatorio). Para ser mecánico, debe venir sin signos de alarma: déficit neurológico (lo más importante), lumbago inflamatorio, baja de peso/antecedente de cáncer, fiebre, o antecedente de traumatismo/osteoporosis. La irradiación del dolor NO es signo de alarma (cambia el nombre a lumbociática o cervicobraquialgia, pero no la gravedad). El manejo es reposo relativo + AINEs en agudo, educación y kinesioterapia de fortalecimiento. En lumbago mecánico sin signos de alarma NO se piden imágenes. La resonancia magnética se indica con signos de alarma, no mejoría en 2 semanas, o persistencia de síntomas más de 6 semanas. No se opera la mayoría: indicación quirúrgica solo con déficit neurológico severo (compresión medular, cauda equina) o lumbago que no responde a buen tratamiento médico con causa operable (hernia, raquiostenosis).